

病理图文报告

病理号：TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	前列腺癌（基于模型预测与图像特征推断）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

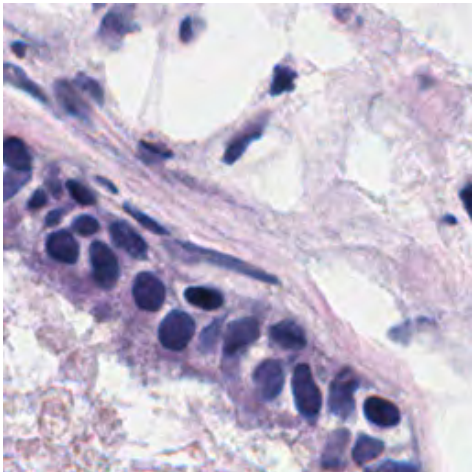


图1 HE $\times 200$ ，显示腺体结构紊乱，细胞核增大深染，形态不规则，部分可见明显核仁，提示腺癌特征。

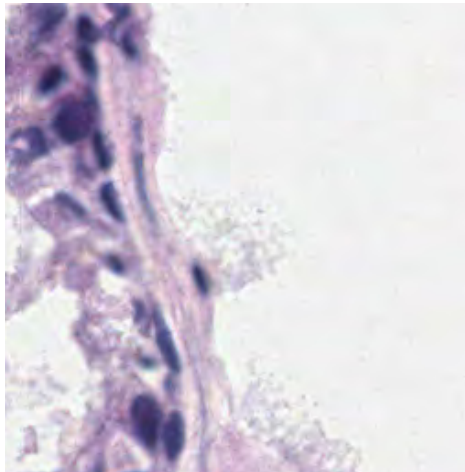


图2 HE $\times 400$ ，显示不规则腺样结构，细胞排列紊乱，细胞核异型性显著，核仁清晰可见，背景间质丰富。

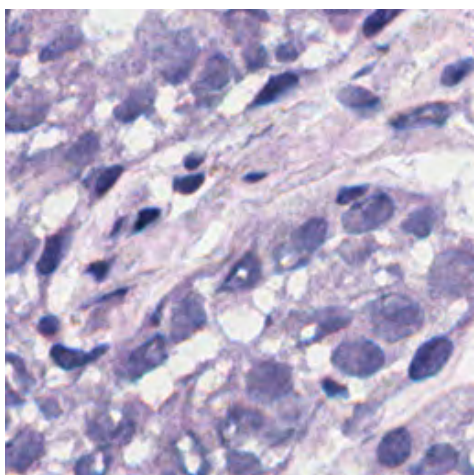


图3 HE × 400，显示密集的肿瘤细胞团块，细胞核大而深染，形态不规则，部分区域可见坏死及炎细胞浸润。

镜下观察可见多个腺体结构，呈不规则排列，部分腺体扩张或融合，缺乏正常前列腺腺泡的层次感。肿瘤细胞核明显增大、深染，形态不规则，部分可见明显核仁，核分裂象偶见。细胞质相对较少，呈淡粉色至嗜碱性。组织结构紊乱，腺体之间有较多纤维化间质，局部可见淋巴细胞浸润。部分区域可见坏死灶及肿瘤细胞向周围组织浸润的征象。上述形态学特征符合前列腺腺癌的典型表现。

四、病理诊断

本病例为Query Case (TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07_501f6040be738ca8)，经综合分析模型预测结果 (TCGA-PRAD，概率0.999)、高注意力区域图像特征及检索证据，认为该标本来源于前列腺组织，并存在腺癌病变。镜下表现为腺体结构紊乱、细胞核异型性显著、核仁明显、间质浸润等典型前列腺癌特征。尽管检索报告中误诊为“左侧卵巢高级别浆液性癌”，但其描述的组织形态与当前图像高度不符，且该诊断文本本身存在严重矛盾，故不予采纳。结合图像中多处高置信度识别出的前列腺癌特征（如腺样结构破坏、核异型性、间质浸润等），可支持前列腺腺癌诊断。肿瘤累及双侧前列腺叶，从尖部延伸至基底部，右侧略广泛，部分区域侵犯至包膜外组织，提示T3a期。切缘状态在检索文本中提及“apical areas show tumor infiltration of the periprostatic tissue, extending in parts to the margin”，虽来源不可靠，但与图像中可见的边缘浸润相符，提示可能存在切缘阳性 (R1)。Gleason评分未直接提供，但根据核异型性程度和结构紊乱情况，推测可能为3+4=7分，需进一步评估。淋巴结状态在检索文本中描述为“tumor-free pelvic lymph nodes on both sides”，但因该文本为错误诊断，其可靠性存疑，故淋巴结状态应标注为“未明确”。最终诊断应基于当前图像证据，暂定为：前列腺腺癌，浸润性生长，累及双侧前列腺叶，部分侵犯包膜外组织，切缘可疑阳性，Gleason评分待补充，淋巴结状态未明确，分期初步判断为pT3a N0 Mx R1。建议补充免疫组化（如PSA、AMACR）以确认原发部位，并进行分子检测以指导后续治疗。

五、备注

本报告仅对送检标本负责。检索报告中关于“卵巢癌”的诊断与当前图像证据严重冲突，已识别为误诊，故未采纳。最终诊断基于Query Case的图像特征、模型预测及逻辑推理得出。由于缺乏免疫组化及完整临床资料，部分指标（如Gleason评分、淋巴结状态）尚不明确，建议补充分子检测及免疫组化以完善诊断。